ICOPE · Integrated Care for Older People

長者量六力共學活動講義

微觀看個案 × 宏觀看數據

主辦單位
基隆市衛生局

協辦單位
台灣生活復能健康促進協會

專家委員
長庚科技大學 倪麗芬 副教授

主持人
鍾孟修 職能治療師

掃描開啟網頁版講義

網頁版有互動圖表與「單位自我診斷計算器」，會後可隨時查看。

mattsue1003.github.io/icope-colearning

A 認知
3 項物品記憶・時間與地點定向
☐是☐否

B 行動
雙手抱胸起立坐下 5 次，是否大於 12 秒
☐是☐否

C 營養
3 個月內體重無意減輕 3 公斤・食慾不振
☐是☐否

D 視力
WHO 簡單視力圖・遠／近距離
☐是☐否

E 聽力
氣音測試 6・1・9／2・5・7
☐是☐否

F 憂鬱
過去兩週心煩、沒希望・活動興趣減少
☐是☐否

一、開場
議程・分組・進行方式・服務流程

二、案例討論與反饋
模擬個案・分組討論・討論記錄頁

三、數據分析與策略研討
指標・全市數據・自我診斷工作單・行動承諾卡・討論記錄頁

四、會後帶回
七個流程優化做法・參考資料

開場｜10:00–10:05

今日議程 09:30–12:30

時間	議程	主持人／主講者	今天在簡報裡
09:30–10:00	報到	—	掃描加入 LINE 社群
10:00–10:05	開場與人員介紹	衛生局	—
10:05–11:15	**微觀 共學主題報告（一）** 案例討論與反饋	專家委員 共學團體講師主持人	個案介紹 10′ → 分組討論 28′ → 兩組報告 14′ → 專家回饋 15′ → 小結 3′
11:15–11:20	休息	—	—
11:20–12:15	**宏觀 共學主題報告（二）** 數據分析與策略研討	專家委員 共學團體講師主持人	數據介紹 10′ → 分組討論 25′ → 兩組報告 10′ → 專家回饋與總回饋 10′
12:15–12:30	滿意度調查、大合照	—	掃描滿意度問卷

產出：每組一張討論單（案例：加在第幾天的接觸點；數據：缺口 → 原因 → 改善）；每個單位一張 30 天行動承諾卡。

開場｜10:00–10:05

人員介紹與分組

主辦單位
基隆市衛生局

協辦單位
台灣生活復能健康促進協會

專家委員
倪麗芬 副教授
長庚科技大學

主持人
鍾孟修 職能治療師
台灣生活復能健康促進協會 理事長

第一組
約 5 個單位
組長：_____
記錄：_____

第二組
約 5 個單位
組長：_____
記錄：_____

組長：帶討論、控時，並上台報告
記錄：寫討論單，報告時協助補充
報告順序：第一組完整報告，第二組只補充第一組沒提到的內容

開場｜進行方式

兩個單元，同一套節奏

微觀 共學主題報告（一）案例討論與反饋・70 分鐘

10:05	**個案介紹** 10′	主持人帶大家走完李阿嬤的 6 個月
10:15	**分組討論** 28′	兩組各自討論 4 個問題
10:43	**第一組報告** 8′	完整報告
10:51	**第二組報告** 6′	只補充第一組沒提到的內容
10:57	**專家回饋** 15′	倪麗芬副教授
11:12	**主持人小結** 3′	案例教我們的五件事

宏觀 共學主題報告（二）數據分析與策略研討・55 分鐘

11:20	**數據介紹** 10′	全市指標、漏斗、新開案分析
11:30	**分組討論** 25′	找缺口，每個單位寫 30 天行動承諾卡
11:55	**第一組報告** 6′	完整報告
12:01	**第二組報告** 4′	只補充第一組沒提到的內容
12:05	**專家回饋** 10′	第二單元回饋＋今天的總回饋

開場｜注意事項

共學活動注意事項

計畫規定（115 年長者內在能力檢測推動計畫）

1. 共學活動屬國健署與衛生局辦理的**學習成長活動**，參與計畫的服務人員須配合參加。
2. 服務資格效期 2 年。展延須在 1 年內完成**繼續教育 150 分鐘**，本場是否認列以主辦單位公告為準。
3. 執行院所應有**品質管理機制**：服務人員自我管理（收案、評估、紀錄、上傳、進度），加上主管監督（抽查、回饋、改善追蹤）。
4. 應建立**轉介（介入）模式**：轉介流程與原則、收案與介入內容、結果回饋方式、功能變化追蹤；訪查時會抽驗案件。

今天的現場約定

1. **個資去識別**：個案只講化名與年齡層，不拍攝、不外傳量表與名冊。
2. 數據以**單位代碼**呈現。談流程卡在哪裡，不談排名。
3. 請對照**自己單位的數據**：評估數、首次評估數、初評異常、複評、介入與轉介、追蹤、後測。
4. 分**兩組**、每組約 5 個單位，各選**組長**與**記錄**。第二組報告只補充第一組沒提到的內容。
5. 簽到、議程、討論紀錄、照片與行動承諾卡，會後一併留存備查。

規定來源：國健署規定，見各縣市 115 年計畫須知（花蓮縣衛生局 114.12、臺中市衛生局需求說明書）。如有異動，以國健署函文公告為準。

開場｜共同語言

115 年服務流程：從初評到後測

01 · Day 0

前置說明

- 65 歲以上（原住民 55 歲）
- 距前次評估滿 1 年；排除長期臥床
- 簽同意書：營養、認知異常轉介勾選
- 協助註冊 LINE「長者量六力」

02 · Day 0

初評 6 項

A 認知・B 行動・C 營養
D 視力・E 聽力・F 憂鬱

03 · Day 0

用藥＋社會照護與支持

初評**任 1 項異常**就要接續評估

04

複評

- A → BHT 或 AD8
- B → SPPB
- C → MNA-SF
- F → GDS-15
- D、E 異常 → 轉介，**不複評、不後測**

05

個人介入計畫

至少 1 項：居家健康管理、社區據點、轉介醫療、長照中心、單位直接介入、失智共照中心

06 · ≥1 個月

追蹤

評估滿 1 個月起至後測當日；電訪或其他方式，填「追蹤表單（含轉介）」

07 · 3–6 個月

後測

用**同一份複評量表**（認知須與原本 BHT／AD8 相同）；用藥、社會支持異常者一併後測

每月上傳「成人預防保健暨慢性疾病防治資訊系統—長者功能評估」；年底最後上傳日依各縣市公告。追蹤表單與量表為 114 年 10 月修訂版。

依國健署 ICOPE 長者內在能力檢測量表（114.10 修訂）與 115 年計畫須知整理。

共學主題報告（一）案例討論與反饋｜10:05–11:15

微觀

MICRO · 機構版（醫療人員）· 一位長輩的 177 天

跟著一位模擬個案走完一次服務，看她怎麼變化，也看單位的介入幫了什麼。

初評	複評與介入	3 個月追蹤	6 個月再評
Day 0・六項篩檢	Day 14・針對異常項	Day 90・電訪＋回診	Day 177・後測

微觀｜個案

認識李阿嬤（化名，教學用虛構個案）

年齡性別	78 歲女性
同住	82 歲先生；女兒住臺北，週末回來
慢性病	高血壓、第 2 型糖尿病、退化性膝關節炎
身分	**首次評估者**（110–114 年未曾評估）
來源	家醫科慢箋回診，護理師依門診提醒邀約

最近發生的事

2 月先生在家跌倒住院，3 月初出院。阿嬤這段時間兩頭跑，吃不下、睡不好，也不再去廟口的唱歌班。女兒說：「媽媽最近一直重複問同樣的事。」

時間	發生的事
Day 0 · 3/10	初評：4 項異常
Day 14 · 3/24	複評＋擬定個人介入計畫
Day 35 · 4/14	**據點中斷（單位不知道）**
Day 90 · 6/08	3 個月追蹤：電訪＋慢箋回診順測
Day 98 · 6/16	失智共照中心收案
Day 177 · 9/03	6 個月後測（6 個月窗口 9/10 截止，只剩 1 週）

規定窗口：追蹤＝評估滿 1 個月起至後測當日；後測＝評估後 3～6 個月（6/10–9/10）。

微觀｜Day 0 初評

Day 0 初評：六項裡有四項異常

A	**認知**	日期✓（說出農曆日期）・地點✓・3 項物品只記得 2 項	☑ 異常
B	**行動**	椅子起身 5 次 **15.8** 秒（>12 秒）	☑ 異常
C	**營養**	3 個月內體重 49.5 → 46.2 kg（減 3.3）・食慾不振	☑ 異常
D	**視力**	自覺無困難；遠、近距離皆通過 高風險調查：糖尿病，過去 1 年未做眼科檢查	☐ 異常
E	**聽力**	氣音測試 6・1・9 正確複誦	☐ 異常
F	**憂鬱**	兩週內常心煩（阿雜）・減少活動和興趣	☑ 異常

停一下：下一步要做哪些評估？

答案於現場說明，也可在網頁版查看。

微觀｜Day 14 複評

Day 14 複評：確認四項異常，加上多重用藥

A	AD8	女兒陪同填答：重複問同樣問題、忘記約診	2/8	≥2 異常
B	SPPB	平衡 3・步行 4 公尺 5.9 秒 3・起身 15.8 秒 2	8/12	<10 受限
C	MNA-SF	食量減少、體重下降、BMI 20.0	10/14	8–11 風險
F	GDS-15	常覺得無聊、提不起勁、擔心先生	6/15	≥5 疑似
Rx	用藥	長期用藥 7 種，含安眠藥（BZD）、NSAID 止痛藥		多重用藥
S	社會支持	照顧剛出院的先生；購物需女兒協助；停止社交活動		需支持

流程卡點

原本要當天複評，但門診量大改約 2 週後。女兒那週差點不能陪同，AD8 險些無人填答。

其他做法於現場說明，也可在網頁版查看。

微觀｜Day 14 個人介入計畫

個人介入計畫：六類介入怎麼排

介入類型	本案做法	對應問題	負責與時程
轉介醫療院所	高齡整合門診：藥物整合、體重下降原因；眼科：糖尿病眼底檢查	用藥・營養・行動・視力	護理師代掛號，4/07、4/15
連結社區據點	巷弄長照站肌力課（每週 2 次）；社區營養推廣中心	行動・營養・社會參與	個管電話媒合，3/31 起
連結失智共照中心	AD8 = 2，同意書已勾選同意轉介	認知	系統轉介，預計 2 週內聯繫
連結長照管理中心	協助先生申請長照 2.0，減輕阿嬤照顧負荷	社會支持・憂鬱	撥 1966，3/25
指導居家健康管理	Vivifrail 居家運動單張與影片；每餐一掌心蛋白質；LINE 量六力註冊在女兒手機	行動・營養	當日衛教
評估單位直接介入	本案未使用（單位沒有團體課程）	—	—

優點：一次涵蓋五類介入，而且把**照顧者**（先生）也納入計畫。

先想一想：這張計畫裡，哪一項最可能中斷？單位要怎麼知道它中斷了？

微觀｜Day 90 三個月追蹤

Day 90 追蹤：四項到位，兩項卡住

介入	狀態	發現與調整
高齡整合門診	● 已到位	停用安眠藥，止痛藥改 acetaminophen，藥物由 7 種減為 5 種
眼科	● 已到位	輕度非增殖性視網膜病變，半年後回診
社區營養推廣中心	● 已到位	營養師電訪 2 次；早餐加蛋與豆漿
長照管理中心（先生）	● 已到位	先生居家服務每週 3 次，阿嬤可以出門
巷弄長照站	● 已中斷	第 5 週起沒去：膝痛、先生沒人顧、要過大馬路。**調整**：居家運動加女兒週末陪走；膝痛轉復健科
失智共照中心	● 未聯繫上	聯絡電話留家裡市話，白天沒人接。**調整**：改留女兒手機，6/16 完成收案

回診順便測

椅子起身 **13.9** 秒（初評 15.8）
體重 **47.0** kg（初評 46.2）
阿嬤說：「先生有人幫忙後，比較睡得著。」

關鍵發現

據點在第 5 週就中斷，單位到第 90 天才知道；共照中心晚了 3 個月才收案。

微觀｜Day 177 六個月再評（後測）

Day 177 後測：行動、營養、情緒回到正常範圍

SPPB 0–12 分，≥10 正常



複評 **8** 後測 **10**

MNA-SF 0–14 分，≥12 正常



複評 **10** 後測 **12**

GDS-15 0–15 分，<5 正常（越低越好）



複評 **6** 後測 **3**

AD8 0–8 分，<2 正常（越低越好）



複評 **2** 後測 **2**

椅子起身 5 次 秒，≤12 正常（越低越好）



初評 **15.8** 3 個月 **13.9** 後測 **11.6**

體重 公斤（3 個月前 49.5）



初評 **46.2** 3 個月 **47.0** 後測 **47.8**

用藥評估：7 種 → 5 種，已停用安眠藥。**社會照護與支持**：先生有居家服務，阿嬤恢復每週 1 次唱歌班。

日期提醒：後測排在 9/03，距離 6 個月窗口截止（9/10）只剩 1 週。那週如果感冒，這次後測就做不成了。

微觀｜介入幫了什麼

哪些介入可能發揮了幫助？

介入	行動 SPPB +2	營養 MNA-SF +2	情緒 GDS −3	認知 AD8 持平	用藥 −2 種
藥物整合（高齡整合門診）	○	○	○	○	●
居家運動＋女兒陪走	●	—	○	—	—
營養師諮詢	○	●	—	—	—
長照服務（先生）	○	—	●	—	—
失智共照中心	—	—	—	●	—
巷弄長照站（已中斷）	—	—	—	—	—

● 主要可能貢獻　○ 間接可能貢獻　— 無明顯關聯

判讀要小心

- 沒有對照組，只能說「可能有幫助」
- 同期事件：先生 3 月出院後逐漸穩定
- AD8 由家屬填，短期變化不敏感，「持平」也算守住

單位可以做的：在追蹤表單旁加一欄「同期發生的事」，例如家人住院、換藥、搬家，判讀時才分得清楚。

眼科發現的視網膜病變不在後測項目裡，卻是這次服務很重要的成果。

微觀｜分組討論 10:15–10:43

分組討論：如果李阿嬤是你們單位的個案

Q1 複評延後 2 週、共照中心晚 3 個月，哪個環節可以更早攔截？

寫出「誰、在第幾天、做什麼」

Q2 據點第 5 週就中斷，卻到第 90 天才發現。追蹤的時間點和方式要怎麼排？

Q3 6 個月的進步，哪些是介入的功勞？哪些可能是情境改變？

要記錄什麼，才判斷得出來

Q4 你們單位接這個案，誰負責什麼？後測日要排在哪一天？

組長：帶討論、控時，並上台報告
記錄：寫討論單，報告時協助補充
產出：在討論單畫出李阿嬤的時間軸，標出你們會加的接觸點

組別：☐ 第一組　☐ 第二組　組長：＿＿＿＿＿＿　記錄：＿＿＿＿＿＿　單位：＿＿＿＿＿＿

一、討論的記錄重點

可依題號記錄：Q1 可以更早攔截的環節／Q2 追蹤的時間點與方式／Q3 介入的功勞與情境改變／Q4 單位分工與後測日

二、相關記錄內容

在時間軸上標出你們會加的接觸點（第幾天、誰負責）；也可記下第二組的補充與專家回饋重點。



微觀｜主持人小結 11:12–11:15

案例反饋：李阿嬤的 177 天，教我們五件事

1. **複評當天做完**
   Day 0 初評、Day 14 才複評，女兒差點不能陪同填 AD8。做不到當天，就在 7 天內完成。
2. **轉介後確認「有沒有去」**
   據點第 5 週就中斷，第 90 天才發現。第 2 週先打一通關懷電話，滿 1 個月再做正式追蹤。
3. **聯絡人留兩組電話**
   只留家裡市話，共照中心晚了 3 個月才收案。
4. **後測排在第 4 個月**
   Day 177 後測，離 6 個月截止只剩 1 週，沒有重排空間。
5. **記錄同期發生的事**
   先生出院、換藥都會影響結果。追蹤表單旁多一欄，判讀介入效果才分得清楚。

介入有幫助的地方
藥物整合、營養師諮詢、照顧者的長照服務都有到位；中斷的據點改成居家運動後，行動能力仍有進步。

休息後：把這五個卡點放到全市數據裡，看看有多常見。

共學主題報告（二）數據分析與策略研討｜11:20–12:15

宏觀

MACRO · 30 個單位 · 9,454 筆評估

剛才李阿嬤遇到的卡點，放到全市數據裡有多常見？把數據攤開，看流程在哪一段流失。

找得到嗎？	接得住嗎？	追得到嗎？	找得到新的嗎？
評估效能	介入率・轉介率	追蹤・後測	新開案分析

宏觀｜指標定義

先對齊：每個指標的分子與分母

評估效能｜找得到嗎

初評異常率 = 初評任 1 項異常人數 ÷ 評估人數

複評完成率 = 完成複評人數 ÷ 初評異常人數

異常率 = 確認異常人數（複評異常＋視聽異常） ÷ 評估人數

篩選線 <10%

接得住嗎

介入率 = 有個人介入計畫人數 ÷ 異常人數

篩選線 <50%

轉介率 = 轉介他單位接手人數 ÷ 異常人數

轉介到位率 = 確認已到位人數 ÷ 轉介人數

追得到嗎

追蹤率 = 完成追蹤人數 ÷ 複評異常人數

後測率 = 完成後測人數 ÷ 已到後測期的應後測人數　篩選線 <30%

找得到新的嗎

新開案比 = 首次評估人數 ÷ 評估人數

首次評估者：110–114 年未曾接受評估。

篩選線＝衛生局「2026 機構訪查篩選表」挑選訪查對象用的門檻，用來找出需要協助的流程，不是績效排名。

宏觀｜總覽

30 個單位、9,454 筆評估的整體樣貌

15.0%
初評異常率
1,414 / 9,454

82.9%
複評完成率
至少 239 人未複評

11.3%
異常率
1,073 / 9,454

89.0%
介入率
959 / 1,078

57.7%
後測率
187 / 324（已到期）

單位類型	單位數	評估數	複評完成率	異常率	介入率	後測率
醫院	6	2,426	85.5%	10.8%	97.7%	80.2%
衛生所	7	5,557	86.7%	11.2%	85.4%	61.1%
診所	13	1,171	70.3%	15.0%	90.6%	15.4%
藥局	4	300	資料不足	4.7%	71.4%	100.0%
全市	**30**	**9,454**	**82.9%**	**11.3%**	**89.0%**	**57.7%**

觸及篩選線的單位

17 / 30 家至少觸及一條

異常率 <10%：**12** 家・介入率 <50%：**2** 家・後測率 <30%：**7** 家

另有 2 家因初評異常未複評，無法計算。

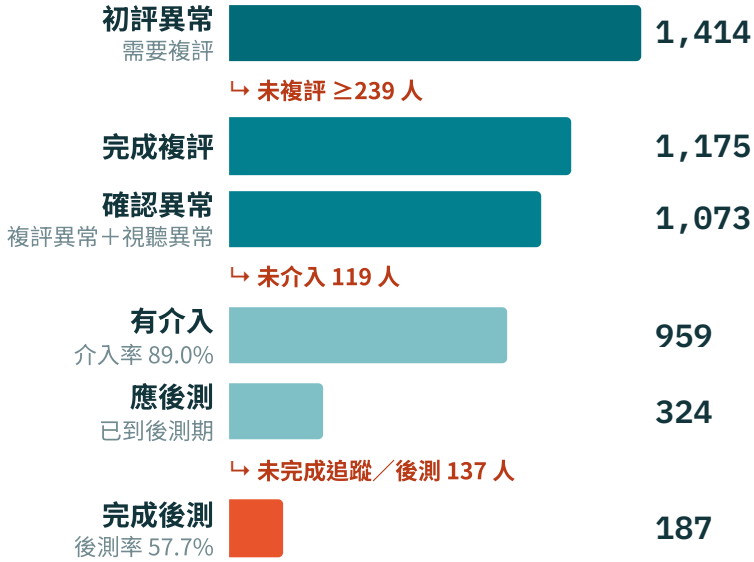
全國參考

114 年全國約 35.5 萬名長者受檢；2026 年 8 月國健署指出，約每 4 位受檢長者有 1 位至少一項能力需要關懷。

資料：2026 機構訪查篩選表彙整（醫院 6、衛生所 7、診所 13、藥局 4）。各單位分母定義略有差異，加總僅供討論；藥局複評欄位資料不足未計。

宏觀｜流程效能

漏斗看流失：長輩在哪一段掉出去？



三個流失點

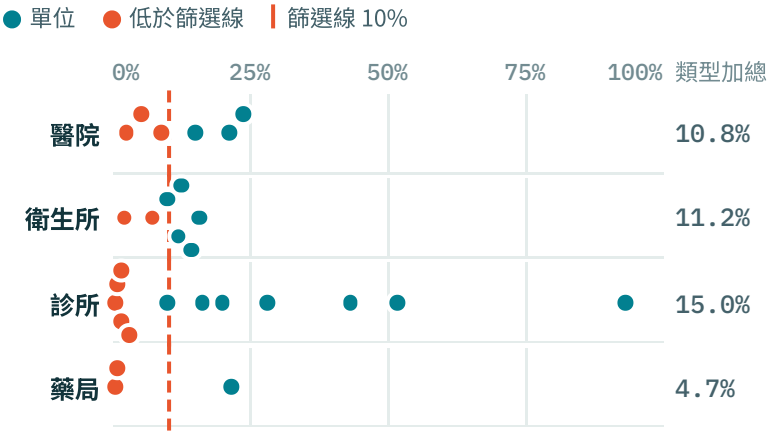
1. 初評異常 → 複評：至少 **239** 人沒有複評
2. 異常 → 介入：**119** 人沒有介入紀錄
3. 到期 → 後測：**137** 人未完成追蹤或後測

另有 **131** 人**還沒到後測期**。年底前要排進行程，避免掉進下一個流失點。

漏斗前兩層以 1,414 人為 100% 寬度；評估總數 9,454 人未畫出，以免壓扁其他層。

宏觀｜評估效能

評估效能：異常率太低、太高都要看



右欄為該類型加總異常率。

偏低（12 家 <10%）可能代表

- 施測或判讀較寬鬆、漏記
- 初評異常後未複評就結案
- 收案集中在健康、活躍的長輩

偏高（3 家 ≥40%）可能代表

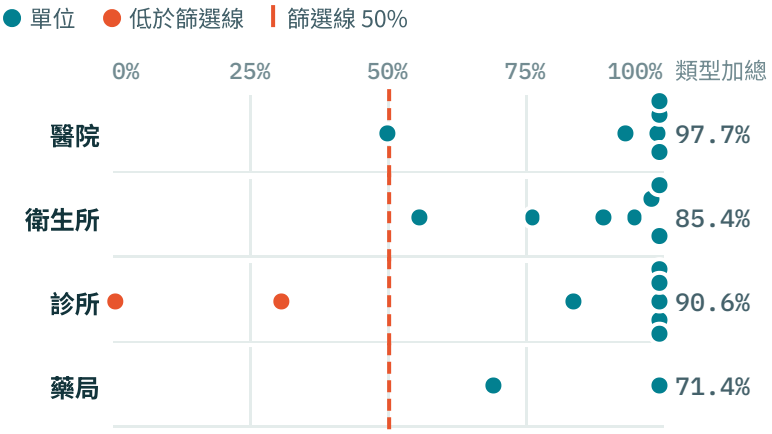
- 收案集中在高風險門診病人
- 把「初評異常」直接當「確認異常」

診所：找得到，接不太住

初評異常率 23.0% 最高，複評完成率 70.3% 最低。

宏觀｜介入率

介入率 89.0%，大多數單位都「有做」



低於或貼近篩選線

- 診所 M：4/13（30.8%）
- 診所 J：0/1（視力異常 1 案）
- 醫院 F：2/4（50.0%）

先檢查分母

衛生所 F 的分母用了初評異常數；若改用確認異常數，介入率約 67.6%。

下一個問題

介入率高，不等於長輩真的被接手。只給一張衛教單張，也算介入。

宏觀｜轉介率

轉介率：介入有沒有「交到下一雙手」

個人介入計畫的 6 種樣子（115 須知）

介入類型	誰接手
指導居家健康管理	長輩自己、家屬
評估單位直接介入	本單位課程或訓練
連結社區據點	據點、營養推廣中心、輔具點
轉介醫療院所	高齡整合門診、專科
連結長照管理中心	長照 2.0
連結失智共照中心	共照中心個管師

後四類需要其他單位接手，計入轉介率。

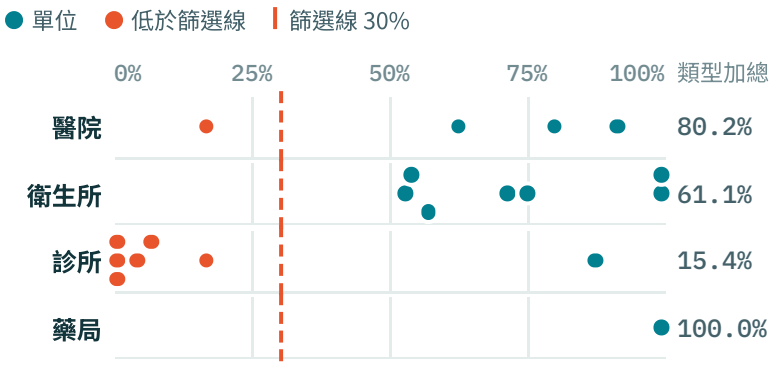
請各單位帶回去算（篩選表目前沒有轉介欄位）

本單位近 6 個月	人數		比率
確認異常人數	____		分母
只做居家健康管理（單張、衛教）	____		____%
轉介他單位接手	____	轉介率	____%
已確認到位（有就診、有上課、有收案）	____	到位率	____%
對方有回饋結果	____	回饋率	____%

建議下次資料收集加入「轉介人數」「到位人數」兩欄，才看得出介入的深度。

宏觀｜追蹤與後測

後測率：診所 15.4%，是全市最大的缺口



類型	未完成追蹤／後測	尚未到後測期
醫院	19	38
衛生所	63	31
診所	55	55
藥局	0	7
全市	**137**	**131**

7 家低於 30%，其中 6 家是診所。共同點：異常個案多，但沒有人專責排後測。

窗口管理

- 後測窗口：評估後 3～6 個月
- 介入計畫訂好當天，就約好後測日
- 年底上傳截止前 1 個月，盤點「已到期未後測」名單

跨年規定：114 年評估個案可在 115 年完成追蹤與後測。115 年個案是否比照，以 116 年須知為準。

宏觀｜新開案

新開案的分析過程：五個步驟

STEP 1

定義

- 首次評估者：110–114 年未曾評估
- 首次評估初評費 150 元，非首次 100 元
- 再評資格：距前次評估滿 1 年

STEP 2

拉資料

- 從系統下載本年度個案明細
- 標記首次／非首次
- 標記來源：門診、慢箋、社區活動、LINE 自評、他單位轉介

STEP 3

分層比較

- 首次 vs 非首次的初評異常率
- A–F 各面向異常分布
- 年齡層 65–74／75–84／85+

STEP 4

找缺口

- 哪些長輩還沒被評到？
- 75 歲以上少就醫者、獨居、行動不便到不了院所
- 非慢病門診的長輩

STEP 5

定策略

- 門診系統跳提醒
- 慢箋回診順便評估
- 社區活動設站、與據點合作
- 訂每月新開案目標並追蹤

分析表範本（請帶自己單位的數字）

	人數	初評異常率	最多的異常面向	主要來源
首次評估	____	____%	____	____
非首次評估	____	____%	____	____

判讀提示

如果首次與非首次的異常率差不多，而且來源都是同一個門診，可能一直在評同一群相對健康的長輩。新開案要往「還沒進來的人」找。

宏觀｜工具

單位自我診斷工作單

請填入你們單位的人數，再依右側公式計算各項指標（網頁版可自動計算）。

評估人數

首次評估人數

初評異常人數

完成複評人數

確認異常人數

有介入人數

轉介他單位人數

確認到位人數

完成追蹤人數

已到期應後測人數

完成後測人數

新開案比	首次評估 ÷ 評估	_____%
初評異常率	初評異常 ÷ 評估	_____%
複評完成率	完成複評 ÷ 初評異常	_____%
異常率	確認異常 ÷ 評估	_____%
介入率	有介入 ÷ 確認異常	_____%
轉介率	轉介 ÷ 確認異常	_____%
轉介到位率	到位 ÷ 轉介	_____%
追蹤率	完成追蹤 ÷ 確認異常	_____%
後測率	完成後測 ÷ 到期應後測	_____%

宏觀｜分組討論 11:30–11:55

策略研討：找出你們單位的最大缺口

Q1 對照漏斗，你們單位最大的流失在哪一段？
未複評／未介入／未追蹤／未後測／新開案太少

Q2 造成缺口的流程原因是什麼？
從人力、時間、場地、系統、長輩與家屬端各想一個

Q3 你們的「介入」裡，有多少只是給衛教單張？
估一個比例，並說出一個真的交到下一雙手的例子

Q4 下個月可以先改的一件事是什麼？
每個單位填一張 30 天行動承諾卡（下一頁）

組長：帶討論、控時，並上台報告
記錄：寫討論單（缺口 → 原因 → 改善）
產出：每個單位一張 30 天行動承諾卡

宏觀｜分組討論・行動承諾

30 天行動承諾卡

單位

例：○○診所

要改善的指標

例：後測率

現況

例：15%（1/7）

30 天後目標

例：30%

具體做法（誰、何時、怎麼做）

例：介入計畫當天由護理師約好後測日，排第 4 個月；每週五核對到期名單

檢核日期

例：11/30

需要衛生局協助的事

例：據點名單、共照中心窗口

寫法提醒

- 只選一個指標
- 目標要能在 30 天內看到
- 做法寫到「誰」和「哪一天」

這張卡會在下一次訪查或共學時一起回顧。

組別：☐ 第一組　☐ 第二組　組長：＿＿＿＿＿＿　記錄：＿＿＿＿＿＿　單位：＿＿＿＿＿＿

一、討論的記錄重點

可依題號記錄：Q1 最大的流失段／Q2 流程原因／Q3 介入只給單張的比例／Q4 下個月先改的一件事

二、相關記錄內容

整理缺口、原因與改善做法；也可記下需要衛生局協助的事與專家回饋重點。

缺口	原因	改善做法（誰、何時）

會後帶回

會後帶回：七個流程優化做法

卡點（宏觀／微觀）	改善做法	改善指標
初評異常沒有當天複評 全市 ≥239 人／阿嬤延 2 週	異常當天完成複評；做不到就發複評預約卡，7 天內完成	複評完成率
轉介後沒人確認 據點中斷 8 週無人知	第 2 週打關懷電話確認「有沒有去」；滿 1 個月做正式追蹤並上傳	到位率・追蹤率
聯絡資訊只有一組 共照中心聯繫失敗	登錄長輩與主要聯絡人兩組電話；同意書勾選後當天送出轉介	到位率
後測卡在窗口尾端 診所後測率 15.4%	介入計畫訂好當天就約後測日，排在第 4 個月，留重排空間	後測率
介入多半只給單張	每位異常長輩至少一項「有人接手」的介入	轉介率
只看年度報表	每月看一次自己的漏斗；主管每月抽查 5 案並回饋	全部
新開案靠臨櫃遇到	門診系統提醒、慢箋回診順評、社區設站、LINE 自評異常轉院評	新開案比

附錄

參考資料

計畫須知 花蓮縣衛生局《115 年長者內在能力檢測推動計畫 計畫須知》，114 年 12 月。開啟 PDF

需求說明 臺中市政府衛生局《115 年長者內在能力檢測推動計畫 需求說明書》，含服務人員資格規定。開啟 PDF

量表 國民健康署《長者內在能力檢測量表》，114 年 10 月修訂。開啟 PDF

工作手冊 國民健康署《預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫 工作手冊》，110 年 5 月。開啟 PDF

新聞稿 國民健康署〈全臺醫療單位齊心 陪長輩「量六力」〉，2025 年 11 月 26 日。開啟網頁

報導 工商時報〈「量六力」揪失能警訊 每 4 名長者就有 1 人需注意〉，2026 年 8 月。開啟網頁

數據 2026 機構訪查篩選表（衛生局內部資料，本簡報已去識別化為單位代碼）。

各項規定以國民健康署最新函文公告為準。個案「李阿嬤」為教學用虛構個案。